BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN - PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

BÀI TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG: CHĂM SÓC ĐÚNG MỖI NGÀY, PHÒNG NGỪA BIẾN CHỨNG

Đối tượng: Người trưởng thành mắc đái tháo đường típ 2 và người chăm sóc.
Thời lượng dự kiến: 7-10 phút.

Mục tiêu: Sau buổi truyền thông, người bệnh biết cách ăn uống, dùng thuốc, chăm sóc bàn chân và xử trí ban đầu khi hạ đường huyết.

1. Hiểu đúng về bệnh đái tháo đường

Kính thưa cô bác, anh chị!

Đái tháo đường là bệnh mạn tính, xảy ra khi cơ thể không tạo đủ insulin hoặc sử dụng insulin không hiệu quả, làm đường trong máu tăng cao. Người bệnh có thể khát nhiều, tiểu nhiều, mệt mỏi, nhìn mờ hoặc sụt cân; nhiều trường hợp không có biểu hiện rõ.

Đường huyết cao kéo dài có thể gây tổn thương tim, mạch máu, mắt, thận và thần kinh. Điều trị đều đặn, ăn uống hợp lý và vận động phù hợp giúp phòng ngừa hoặc làm chậm biến chứng. [1]

2. Ăn uống hợp lý, phù hợp với từng người

Người bệnh cần ăn đúng bữa, kiểm soát lượng thức ăn và không tự kiêng hoàn toàn cơm hay chất bột đường.

Có thể hình dung một đĩa ăn gồm:
• **Một nửa đĩa:** rau ít tinh bột như rau lá, cải, dưa leo.
• **Một phần tư đĩa:** cá, thịt nạc, trứng hoặc đậu phụ.
• **Một phần tư đĩa:** cơm, bún, khoai hoặc thực phẩm có chất bột đường.

Ưu tiên nước lọc; hạn chế nước ngọt, trà sữa và bánh kẹo. Chọn trái cây nguyên miếng với khẩu phần phù hợp thay cho nước ép. Người có bệnh thận, suy dinh dưỡng hoặc đang mang thai cần được tư vấn chế độ ăn riêng. [2]

3. Dùng thuốc đúng và theo dõi đều đặn

Dùng thuốc theo đơn, đúng liều và thời điểm đã được hướng dẫn. Không tự ngừng thuốc khi thấy khỏe hoặc đường huyết ổn định. Nếu quên liều hoặc gặp tác dụng không mong muốn, liên hệ nhân viên y tế để được hướng dẫn.

Đo đường huyết theo kế hoạch điều trị; ghi lại kết quả cùng các biểu hiện bất thường. Khi tái khám, mang theo sổ theo dõi và danh sách thuốc. Nếu thường xuyên bị hạ đường huyết, cần báo bác sĩ để điều chỉnh kế hoạch điều trị. [3]

4. Vận động và kiểm tra sức khỏe

Duy trì vận động đều đặn, bắt đầu nhẹ và tăng dần theo khả năng; lựa chọn hoạt động phù hợp với tình trạng sức khỏe. Không hút thuốc.

Tái khám đúng hẹn để được đánh giá đường huyết, huyết áp, mỡ máu, chức năng thận, mắt và bàn chân theo chỉ định. [1]

5. Bảo vệ bàn chân mỗi ngày

Tổn thương thần kinh có thể làm giảm cảm giác, khiến người bệnh không nhận ra vết thương ở chân. Vì vậy, mỗi ngày cần:

• Quan sát lòng bàn chân, mu chân và kẽ ngón; dùng gương hoặc nhờ người thân hỗ trợ.
• Rửa bằng nước ấm, không nóng; không ngâm chân; lau khô, nhất là kẽ ngón.
• Dưỡng ẩm vùng da khô, tránh bôi vào kẽ ngón.
• Mang giày dép vừa chân, kiểm tra bên trong trước khi mang; không đi chân trần.
• Không tự cắt chai chân hoặc dùng thuốc tẩy chai.

Khi có vết phồng rộp, loét, sưng đỏ hoặc chảy dịch, cần đi khám sớm, kể cả khi không đau. [4]

6. Nhận biết và xử trí hạ đường huyết

Hạ đường huyết có thể gây run tay, vã mồ hôi, đói, hồi hộp, chóng mặt hoặc lú lẫn.

Ở người lớn, khi đường huyết **dưới 70 mg/dL (3,9 mmol/L)** và người bệnh còn tỉnh, nuốt an toàn:

Bước 1. Dùng **15 g đường hấp thu nhanh**, chẳng hạn viên glucose đủ 15 g theo nhãn hoặc khoảng 120 mL nước ép hay nước ngọt có đường.
Bước 2. Chờ **15 phút**, đo lại; nếu vẫn dưới 70 mg/dL, lặp lại.
Bước 3. Khi đường huyết hồi phục, ăn bữa chính hoặc bữa phụ có chất bột đường và đạm.

Nếu bất tỉnh, co giật hoặc không nuốt an toàn: không cho ăn uống, không đổ đường vào miệng; gọi cấp cứu ngay. Dùng glucagon nếu đã được kê và người hỗ trợ đã được hướng dẫn. [3]

Thông điệp cần nhớ

Ăn hợp lý - Dùng thuốc đúng - Vận động phù hợp - Theo dõi đều - Chăm sóc bàn chân.

Trước khi kết thúc, nhân viên tư vấn mời người bệnh nhắc lại: “Khi bị hạ đường huyết, cô bác sẽ làm gì?” và “Những thay đổi nào ở bàn chân cần đi khám sớm?” để kiểm tra mức độ hiểu và hướng dẫn lại khi cần.

Tài liệu tham khảo và căn cứ đối chiếu

1. WHO. Diabetes.

2. CDC. Diabetes Meal Planning.

3. CDC. Treatment of Low Blood Sugar (Hypoglycemia).

4. CDC. Your Feet and Diabetes.

5. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh: giới thiệu hướng dẫn theo QĐ 5481/QĐ-BYT ngày 30/12/2020 và QĐ sửa đổi 1353/QĐ-BYT ngày 23/02/2021.

Biên soạn, tra cứu: 15/10/2026. Bản dự thảo trình bệnh viện duyệt trước khi sử dụng chính thức.